Pneumonia · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Classificar [AIDPI] [SBP]

FR alta	2–12 m ≥ 50 · 1–5 a ≥ 40 · < 2 m ≥ 60
Pneumonia	Só FR alta: amoxicilina 7 dias, retorno 2 dias
Grave	Perigo, tiragem, estridor: 1ª dose e referir

Internar se [SBP]

SatO2 < 92% · desidratação ou não bebe · FR > 70 (< 12 m) ou > 50 · gemência, retração, apneia · tóxico, sonolento · doença de base · complicação · **< 2 meses**.

Exames [SBP]

Ambulatorial: **nenhum**. Internado: RX, hemograma, hemocultura, pesquisa viral. Não: antígeno urinário, RX de controle em quem melhora.

Falha em 48–72 h [SBP]

Adesão e dose · atípico · tuberculose · doença de base · corpo estranho, malformação · **derrame, necrose, abscesso**. Atípico: + macrolídeo. Pneumococo resistente ou *S. aureus*: clindamicina ou linezolida.

Derrame [IDSA] [SBP-C]

Ultrassom. Pequeno, estável: observar. Moderado com desconforto, grande, pus, Gram +, glicose < 50, DHL > 1.000, septação: **dreno fino + fibrinolítico**. Uroquinase 2×/dia, pinçar 4 h: < 1 ano 10.000 UI/10 mL; > 1 ano 40.000 UI/40 mL. Falha em 72 h: VTCA.

Ambulatorial [SBP]

1ª escolha	Amoxicilina **50 mg/kg/dia** 8/8 ou 12/12 h, máx. 4 g/dia, **7 dias**
Atípico	Azitromicina 10 mg/kg/dia, 5 dias · claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12 h (máx. 1 g), 7–10 dias
Alergia	Não IgE: cefuroxima · IgE: clindamicina ou macrolídeo

Internado, não complicada [SBP]

1ª escolha	Ampicilina **50 mg/kg/dose** IV 6/6 h · penicilina cristalina 150.000 UI/kg/dia 6/6 h
< 2 meses	+ gentamicina 7,5 mg/kg/dia 12/12 h; cefalosporina: cefotaxima
Grave, HIV, vacina incompleta	Ceftriaxona ou cefotaxima
O2	SatO2 < 92%: cânula, alto fluxo ou máscara

PAC complicada, IV [SBP-C]

Ampicilina	150–200 mg/kg/dia 6/6 h (máx. 12 g)
Penicilina cristalina	200–250 mil UI/kg/dia 4/4 ou 6/6 h (máx. 24 milhões)
Ceftriaxona	50–100 mg/kg/dia 12/12 h (máx. 4 g)
Cefotaxima	150 mg/kg/dia 6/6 ou 8/8 h (máx. 8 g)
Oxacilina	200 mg/kg/dia 6/6 h (máx. 12 g)
Vancomicina	40–60 mg/kg/dia 6/6 ou 8/8 h (máx. 4 g)

Muito grave: vancomicina + ceftriaxona/cefotaxima + azitromicina. Parenteral ≥ 2–3 semanas; necrose 3–4 semanas.

Não prescrever

Macrolídeo de rotina no escolar · ceftriaxona abaixo de 2 meses · antibiótico novo sem rever a falha · punção da necrose · corticoide de rotina · óleo mineral.